NOTE DE TRAVAIL · OCTOBRE 2026

À qui revient la dette publique ?

Attribuer la dette entre l'État, les collectivités et la sécurité sociale quand l'État finance les deux autres

Colin Baget. Comptes des administrations publiques d'Eurostat (1995-2025) et dette de Maastricht par sous-secteur de l'Insee ; les scripts sont dans `fiscalite/dette/`.

L'essentiel

Fin 2025, l'État et les organismes qui en dépendent portent 84 % de la dette publique (3 460 Md€), les collectivités 8 % et la sécurité sociale 9 %. Ce partage dit qui a emprunté, pas pour qui. L'État verse aux collectivités et à la sécurité sociale 78 Md€ de transferts par an et leur a cédé, en 2024, 110 Md€ de TVA. Son déficit finance donc en partie des dépenses faites ailleurs. En revanche, l'État ne « reprend » guère la dette des autres : les 396 Md€ de dette sociale transférés depuis 1996 l'ont été à la CADES, qui fait partie de la sécurité sociale et les rembourse avec la CRDS et une part de la CSG. La seule grosse reprise par l'État, 16,8 Md€ en 1993, lui a été remboursée par la CADES entre 1996 et 2005.

Réattribuer la dette suppose une règle, et le résultat dépend presque entièrement de la règle choisie. Sur la dette créée depuis 1995, la part de la sécurité sociale va de presque rien si l'on suit l'émetteur, ou les seuls transferts explicites de l'État, à 42 % si l'on traite la TVA affectée comme un transfert de l'État, 46 % si l'on répartit le déficit au prorata de la dépense de chaque administration, et 59 % si l'on répartit par fonction (santé et protection sociale, quel que soit le payeur). L'intuition d'une moitié de la dette « sociale » se vérifie donc avec les règles fondées sur la dépense, appliquées à la dette créée depuis 1995. Elle ne vaut pas pour la dette totale (27 à 32 %) : plus de la moitié de la dette de 2025 est le stock de 1995 et les intérêts accumulés dessus, qu'on ne sait pas réattribuer faute de données antérieures dans la même base.

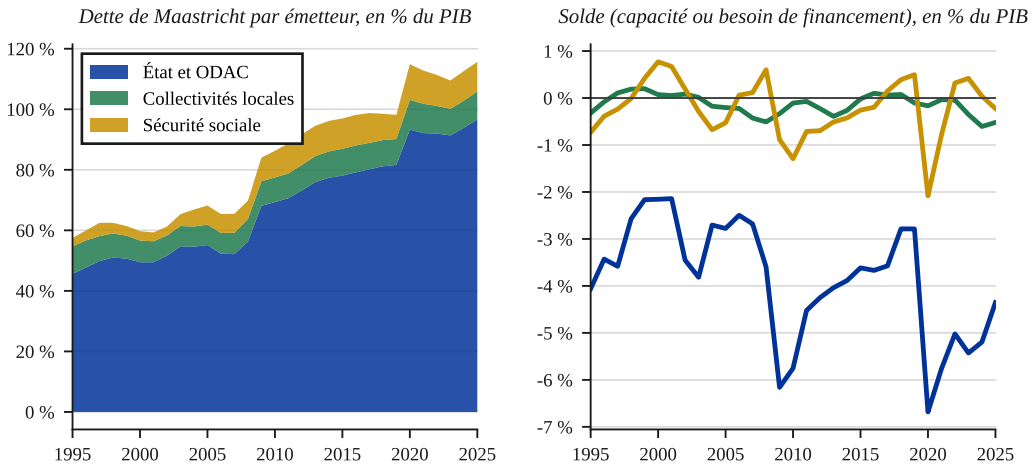
Aucune règle n'est la vraie, parce que la question « qui a causé la dette ? » n'a de réponse qu'avec un contrefactuel. La plus défendable comme convention est le prorata de la dépense : tout euro dépensé par les administrations est emprunté dans la même proportion. Les règles qui comparent les dépenses de chacun à ses « ressources propres » paraissent plus fines, mais ces ressources sont fixées par le Parlement : en 2019, la transformation du CICE a déplacé environ 35 Md€ par an de l'État vers la sécurité sociale dans ces règles, sans rien changer à l'économie.

1. Ce que disent les comptes

Les comptes nationaux découpent les administrations publiques en trois sous-secteurs : l'administration centrale (l'État et les organismes divers d'administration centrale, ODAC, qu'Eurostat ne sépare pas), les administrations locales (APUL) et les administrations de

sécurité sociale (ASSO, qui comprennent les régimes de base et complémentaires, l'assurance chômage, la CADES et les hôpitaux). La dette de Maastricht de chaque sous-secteur est publiée nette de ce qu'il doit aux autres : une obligation de l'État détenue par un régime de retraite n'est pas comptée.

Figure 1. Dette de Maastricht par émetteur et solde de chaque sous-secteur, 1995-2025

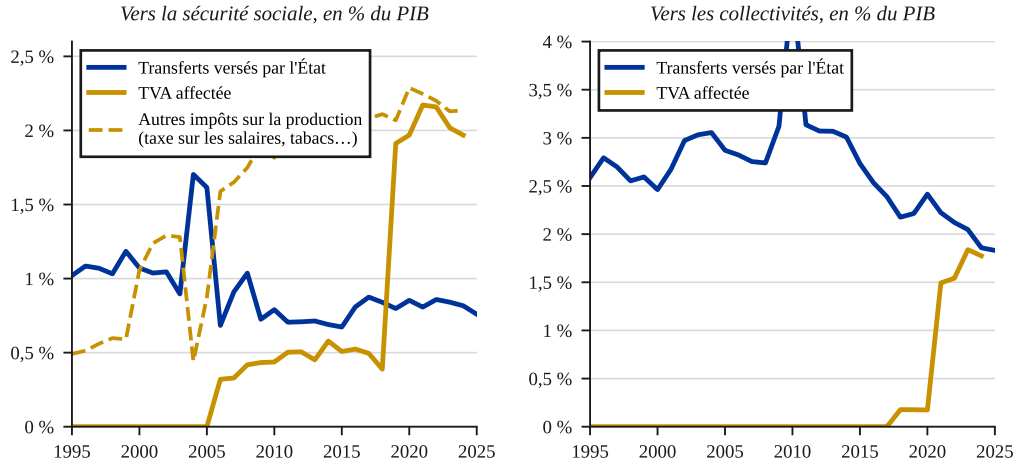


Source : Eurostat, comptes annuels des administrations publiques (gov_10a_main, gov_10a_taxag, gov_10a_exp), PIB (nama_10_gdp) ; Insee, dette trimestrielle de Maastricht par sous-secteur (contributions consolidées, 4e trimestre).
Lecture : fin 2025, l'État et les organismes divers d'administration centrale portent 84 % de la dette publique (3 460 Md€). La sécurité sociale a été excédentaire la plupart des années hors récessions : la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) rembourse chaque année une partie de la dette qu'elle a reprise.

L'État porte presque tout le déficit (figure 1). La sécurité sociale est excédentaire la plupart des années hors récession, pour une raison comptable précise : la CADES perçoit chaque année environ 16 Md€ de CRDS et de CSG pour rembourser le principal de la dette sociale, et ce remboursement n'est pas une dépense en comptabilité nationale. Hors CADES et Fonds de réserve des retraites, les ASSO avaient en 2025 un besoin de financement de 21 Md€ (Fipeco, 2026). La dette des ASSO a pourtant augmenté plus que leurs déficits cumulés (259 Md€ contre 118 Md€ depuis 1995) : les régimes complémentaires et le fonds de réserve accumulent des actifs financiers pendant que la CADES et l'Acoss empruntent, si bien que la dette brute du sous-secteur surestime sa dette nette.

Le point décisif est la manière dont l'État finance les autres. Il le fait par trois canaux (figure 2). Les transferts courants et en capital (dotation globale de fonctionnement, compensations d'exonérations ciblées, subventions d'équilibre) apparaissent comme des dépenses de l'État : 55 Md€ vers les collectivités et 23 Md€ vers la sécurité sociale en 2025. Les impôts affectés, eux, n'apparaissent pas comme des transferts : une fraction de TVA versée à la sécurité sociale est enregistrée comme un impôt de la sécurité sociale, exactement comme si elle l'avait levé elle-même. Ce canal est devenu le premier. La sécurité sociale a reçu 58 Md€ de TVA en 2024 et 63 Md€ d'autres impôts sur la production (taxe sur les salaires, droits sur les tabacs et les alcools…) ; les collectivités, 52 Md€ de TVA depuis la suppression de la taxe d'habitation et de la CVAE. La CSG (163 Md€) est un troisième cas : un impôt créé par l'État en 1991, affecté dès l'origine à la sécurité sociale. Cet enregistrement est une convention discutable. Le système européen de comptes (SEC 2010, §1.78) attribue un impôt à l'administration qui a le pouvoir d'en fixer le taux ; or la fraction de TVA affectée est fixée par le Parlement, pas par la sécurité sociale ni par les collectivités. D'autres pays (Hongrie, Islande) enregistrent ces impôts chez l'État, puis un transfert. Cela change la présentation des soldes, pas la question de fond, qui est celle de la section suivante.

Figure 2. Transferts de l'État et impôts affectés aux autres administrations, 1995-2025



Source : Eurostat, comptes annuels des administrations publiques (gov_10a_main, gov_10a_taxag, gov_10a_exp), PIB (nama_10_gdp) ; Insee, dette trimestrielle de Maastricht par sous-secteur (contributions consolidées, 4e trimestre). Transferts : courants (D7) et en capital (D9).

Lecture : en comptabilité nationale, un impôt affecté est une recette propre de l'administration qui le perçoit, pas un transfert de l'État. Les sauts de 2006-2007 et de 2019 pour la sécurité sociale correspondent à la compensation des allègements généraux de cotisations (panier fiscal, puis TVA lors de la transformation du CICE) ; ceux de 2018, 2021 et 2023 pour les collectivités, au remplacement de la dotation globale de fonctionnement des régions, de la taxe d'habitation puis de la CVAE par des fractions de TVA.

Les sauts de la figure 2 ont une cause commune : l'État compense des recettes qu'il a lui-même supprimées. La loi du 25 juillet 1994 l'oblige à compenser les exonérations de cotisations qu'il décide. Depuis 2006, les allègements généraux sont compensés par un panier d'impôts affectés, depuis 2011 « pour solde de tout compte », c'est-à-dire que le rendement des impôts affectés n'est plus ajusté au coût des allègements. En 2019, le CICE, qui était une dépense de l'État, a été remplacé par une baisse pérenne des cotisations patronales, compensée par une fraction de TVA. Côté collectivités, la TVA remplace depuis 2021 et 2023 la taxe d'habitation et la CVAE. Une partie de la TVA affectée ne finance donc pas un surcroît de dépense sociale : elle remplace des cotisations que l'État a choisi de supprimer pour baisser le coût du travail.

2. Attribuer un déficit suppose un contrefactuel

Une dette n'appartient à une administration que relativement à une question. « Qui a emprunté ? » a une réponse comptable, l'émetteur. « De combien la dette serait-elle plus faible si telle administration avait dépensé moins ? » dépend de ce qu'on suppose sur le financement de cette dépense : si la sécurité sociale avait dépensé 10 Md€ de moins, l'État aurait-il réduit d'autant la TVA qu'il lui cède, ou l'aurait-il gardée pour ses propres dépenses ? Les règles ci-dessous répondent à cette question de manières différentes. Toutes répartissent le même déficit primaire des administrations publiques, année par année de 1996 à 2025 ; les intérêts suivent ensuite la dette attribuée (annexe).

Prorata de la dépense (M1). C'est la règle simple : si les collectivités font 20 % de la dépense, l'État 30 % et la sécurité sociale 50 %, un déficit de 5 points leur est attribué pour 1, 1,5 et 2,5 points. Deux précautions la rendent correcte. La dépense de chacun doit s'entendre hors transferts versés aux autres administrations, sinon la dotation de l'État aux communes serait comptée deux fois, chez l'État qui la verse et chez la commune qui la dépense. Elle doit

aussi exclure les intérêts, qui sont la conséquence de la dette passée et non une dépense à financer comme les autres. En 2025, la sécurité sociale fait ainsi 47 % de la dépense primaire finale des administrations, les collectivités 20 % et l'État 33 %. L'hypothèse implicite est que l'argent est fongible : aucun euro de dépense n'est plus « emprunté » qu'un autre.

Prorata par fonction (M4). Même logique, mais en répartissant entre fonctions (classification COFOG) plutôt qu'entre administrations : la santé et la protection sociale représentent 59 % de la dépense primaire en 2024. C'est la règle qui correspond le mieux à l'idée d'une dette « sociale ». Elle compte dans le social les pensions des fonctionnaires de l'État, le RSA versé par les départements ou les aides au logement payées par l'État.

Transferts suivis jusqu'au dépensier (M2). Ici chaque administration garde son déficit, mais la part de ce déficit qui finance des transferts suit l'argent. Si l'État emprunte 10 et consacre 20 % de ses dépenses à des transferts vers la sécurité sociale, 2 des 10 sont attribués à la sécurité sociale. Cette règle prend au sérieux le partage des ressources décidé par la loi : une administration à l'équilibre avec les ressources qu'on lui a affectées n'a rien emprunté.

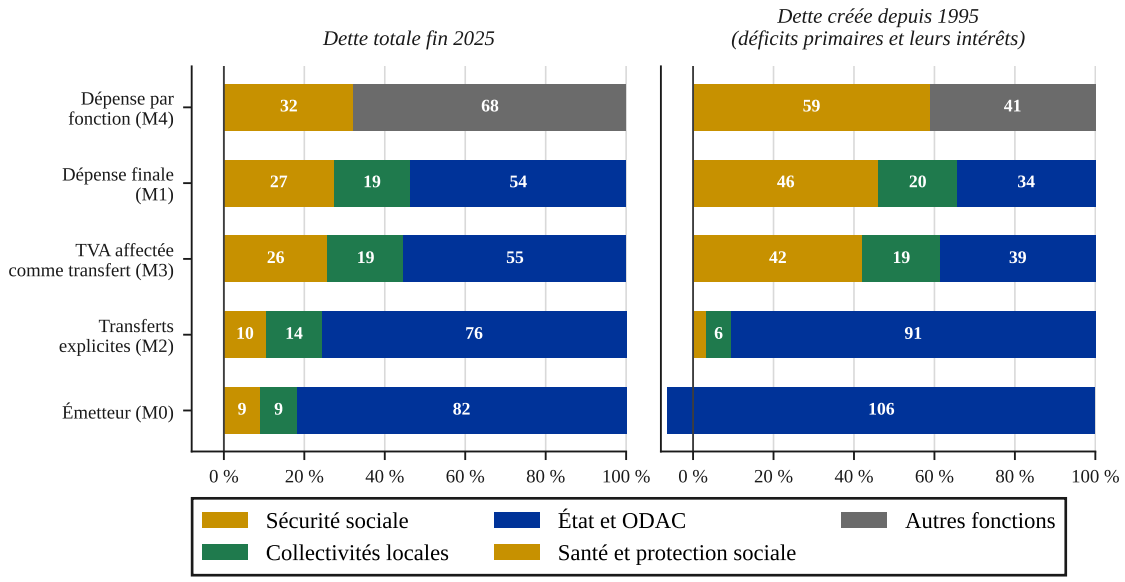
Impôts affectés traités comme des transferts (M3 et M3+). Variante de la précédente où la TVA affectée à la sécurité sociale et aux collectivités est traitée comme un transfert de l'État : l'État est censé la percevoir, puis la reverser. M3+ étend ce traitement à tous les impôts sur la production affectés à la sécurité sociale. La CSG reste une ressource propre de la sécurité sociale dans les deux cas ; la traiter comme un impôt d'État attribuerait à la sécurité sociale plus que la totalité du déficit.

Tableau 1. Part de chaque sous-secteur dans la dette fin 2025, selon la règle d'attribution (en %)

		Dette totale			Dette créée depuis 1995		
	Règle	ASSO	APUL	État	ASSO	APUL	État
M0	Émetteur	9	9	82	−1	−6	106
M2	Transferts explicites suivis jusqu'au dépensier	10	14	76	3	6	91
M3	Idem, TVA affectée traitée comme un transfert de l'État	26	19	55	42	19	39
M3+	Idem, tous impôts indirects affectés à la sécurité sociale	61	15	25	131	8	−39
M1	Prorata de la dépense primaire finale	27	19	54	46	20	34
M4	Prorata de la dépense par fonction (santé et protection sociale)	32		68	59		41

Source : Eurostat, Insee ; calculs de l'auteur (`dette/attribution.py`). La dette créée depuis 1995 (1 355 Md€) est la somme des déficits primaires de 1996 à 2025 et des intérêts qu'ils ont générés. La dette totale y ajoute le stock de 1995, ses intérêts et les ajustements stock-flux, laissés à l'émetteur. Pour M4, la première colonne est la santé et la protection sociale, la troisième les autres fonctions. Une part négative signale des excédents primaires cumulés ; une part supérieure à 100, qu'un autre sous-secteur dégage des excédents.

Figure 3. Part de chaque sous-secteur dans la dette fin 2025, selon cinq règles d'attribution



Source : Eurostat, comptes annuels des administrations publiques (gov_10a_main, gov_10a_taxag, gov_10a_exp), PIB (nama_10_gdp) ; Insee, dette trimestrielle de Maastricht par sous-secteur (contributions consolidées, 4e trimestre). Calculs de l'auteur (dette/attribution.py).

Lecture : la dette créée depuis 1995 (1 355 Md€ fin 2025) est la somme des déficits primaires de 1996 à 2025 et des intérêts qu'ils ont générés ; le reste de la dette est le stock de 1995, ses intérêts et les ajustements stock-flux, laissés à l'émetteur. Une barre qui dépasse à gauche de zéro signale une contribution négative (excédents primaires cumulés). La méthode par fonction répartit la dette entre fonctions et non entre administrations : elle compte en santé et protection sociale le RSA versé par les départements ou les aides au logement.

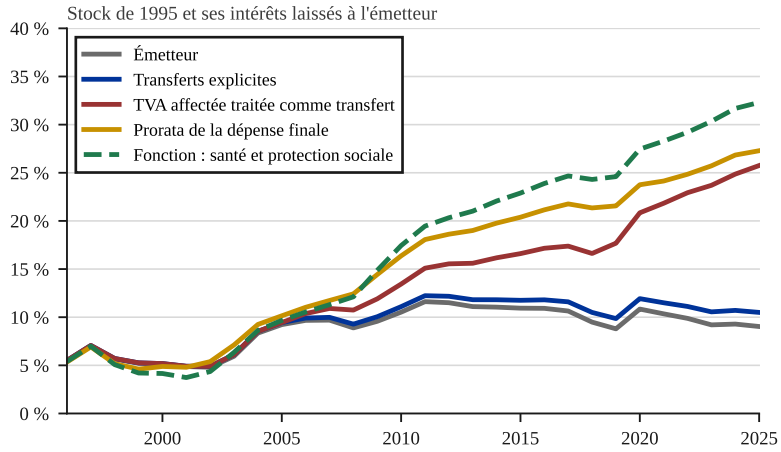
3. Ce que donnent les règles

Les règles se rangent en deux familles, qui donnent des résultats opposés (tableau 1 et figure 3). Les règles fondées sur la dépense (M1, M4) attribuent à la sécurité sociale ou au social 46 à 59 % de la dette créée depuis 1995. Les règles fondées sur l'équilibre de chaque administration avec ses ressources (M2) lui en attribuent 3 % : la sécurité sociale a presque équilibré ses comptes sur trente ans, et les transferts explicites que l'État lui verse sont trop faibles (1 % du PIB) pour que le déficit de l'État la suive beaucoup.

Entre les deux, tout se joue sur le statut des impôts affectés. Traiter la TVA comme un transfert de l'État (M3) fait passer la part de la sécurité sociale de 3 à 42 % de la dette nouvelle, et celle des collectivités de 6 à 19 %. La figure 4 montre d'où vient l'écart : avant 2019 la TVA affectée change peu le résultat ; la bascule du CICE l'accroît d'environ 35 Md€ par an. Or cette bascule n'a modifié ni les prestations ni le coût net pour l'État de la baisse du coût du travail : elle a remplacé une dépense de l'État (le crédit d'impôt) par une moindre recette de la sécurité sociale compensée par de la TVA. Une règle qui fait passer 35 Md€ de déficit d'une administration à l'autre pour un changement d'instrument mesure l'organisation des flux, pas la responsabilité de la dépense. M3+ montre l'excès inverse : en retirant à la sécurité sociale tous ses impôts indirects, y compris ceux qu'elle perçoit depuis des décennies, on lui attribue 131 % de la dette nouvelle et un excédent à l'État.

Une règle de « ressources propres » cohérente compterait la TVA affectée comme une ressource de l'État et, symétriquement, les cotisations exonérées comme une ressource de la sécurité sociale, puisque c'est l'État qui a décidé de les supprimer. Les deux corrections se compensent pour l'essentiel ; ce qui resterait est l'écart entre la TVA reçue et le coût des exonérations. La

Figure 4. Part de la dette totale attribuée à la sécurité sociale, selon la règle, 1996-2025



Source : Eurostat, comptes annuels des administrations publiques (gov_10a_main, gov_10a_taxag, gov_10a_exp), PIB (nama_10_gdp) ; Insee, dette trimestrielle de Maastricht par sous-secteur (contributions consolidées, 4e trimestre). Calculs de l'auteur (dette/attribution.py).

Lecture : la TVA affectée change peu le résultat avant 2019 ; à partir de 2019, la compensation des allègements de cotisations par une fraction de TVA fait basculer environ 35 Md€ par an vers la sécurité sociale dans cette méthode.

Cour des comptes estime que cet écart a joué contre la sécurité sociale : la compensation « pour solde de tout compte » aurait dégradé son solde de 18 Md€ entre 2019 et 2024 (cité par Bach et al., 2026). Une règle bien construite de cette famille donnerait donc un résultat proche de M2, pas de M3. Il faudrait, pour la calculer, les séries d'exonérations et de compensations des annexes aux lois de financement de la sécurité sociale, que ce travail n'a pas mobilisées.

4. Ce que pèse la dette ancienne

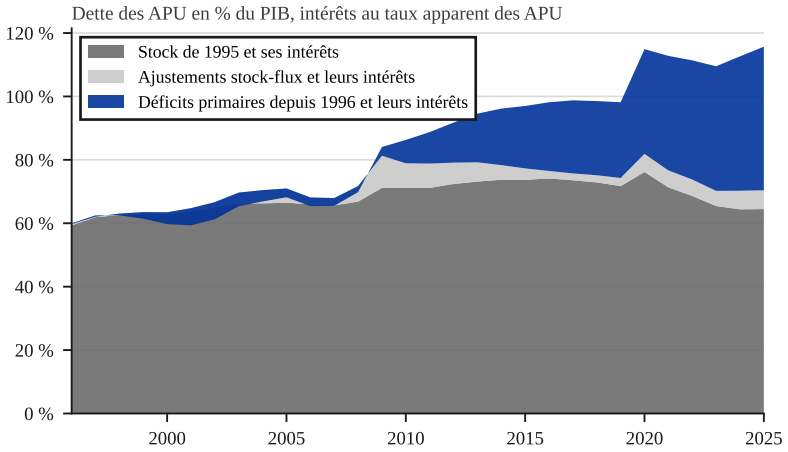
Les 702 Md€ de dette de fin 1995 n'ont jamais été remboursés : les administrations n'ont presque jamais dégagé d'excédent primaire, si bien que les intérêts de cette dette ont été payés par de nouveaux emprunts. Capitalisé au taux apparent des administrations (6,5 % en 1996, 1,3 % en 2020), ce stock représente 1 928 Md€ fin 2025, soit 56 % de la dette (figure 5). Les déficits primaires de 1996 à 2025 (1 211 Md€, dont 675 depuis 2020) et leurs intérêts en font 1 355 Md€ ; les ajustements stock-flux le reste. C'est une décomposition comptable : elle dit seulement que la dette de 2025 dépend autant des choix d'avant 1995 que de ceux d'après.

Faute de comptes par sous-secteur antérieurs à 1995 dans la base actuelle, ce stock est laissé à son émetteur (l'État et les ODAC pour 80 %), ce qui tire toutes les règles vers l'État dans la dette totale. Si l'on supposait que la dette d'avant 1995 avait la même composition que celle créée ensuite, les parts de la dette totale seraient proches de celles de la dette nouvelle. Le choix de l'hypothèse fait varier la part sociale de la dette totale du simple au double ; la dette nouvelle est le résultat le moins fragile.

5. Ce qu'en disent les travaux existants

Le débat a été relancé par Jean-Pascal Beaufret (*Commentaire*, 2023 et 2026), pour qui les retraites « contribuent à plus de la moitié des déficits publics ». Son calcul, fait sur 2021, compte comme déficit des retraites toute la dépense de pensions non couverte par des cotisations au taux de droit commun et des impôts affectés : 71 Md€, dont 45 Md€

Figure 5. Décomposition de la dette des administrations publiques, 1996-2025



Source : Eurostat, comptes annuels des administrations publiques (gov_10a_main, gov_10a_taxag, gov_10a_exp), PIB (nama_10_gdp) ; Insee, dette trimestrielle de Maastricht par sous-secteur (contributions consolidées, 4e trimestre). Calculs de l'auteur (dette/attribution.py).

Lecture : fin 2025, les 702 Md€ de dette de 1995, capitalisés au taux apparent des APU (6,5 % en 1996, 1,3 % en 2020), représentent 1 928 Md€ ; les déficits primaires de 1996 à 2025 et leurs intérêts, 1 355 Md€. C'est une décomposition comptable, pas causale : sans excédents primaires, les intérêts de la dette héritée sont payés par de nouveaux emprunts.

de « surcotisations » des employeurs publics aux régimes de fonctionnaires, qu'il traite comme des subventions. Le calcul est utile pour montrer que l'équilibre affiché des régimes de fonctionnaires repose sur des taux de cotisation employeur de 74 % (civils de l'État) ou 126 % (militaires). Mais c'est une règle de résidu, et elle n'est pas additive : appliquée à la défense ou à l'enseignement, qui n'ont aucune recette affectée, elle leur attribuerait toute leur dépense, et la somme des déficits ainsi calculés dépasserait de loin le déficit réel. Elle donne implicitement aux recettes non affectées de l'État (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA restante) la priorité de financer tout le reste. Au prorata de la dépense, la vieillesse représente 24 % des déficits primaires cumulés depuis 1996.

Sylvain Catherine raisonne par contrefactuel plutôt que par attribution. D'après la reprise de son calcul dans la presse (*JeChange*, 18 août 2026 ; le fil original sur X n'a pas pu être lu), si la France avait consacré depuis 1995 la même part de son PIB que l'Allemagne aux pensions, et que l'économie avait réduit d'autant le déficit, la dette serait de 57,5 % du PIB en 2025 au lieu de 115,7 %, soit environ 1 740 Md€ de moins. Ce calcul répond à une autre question que la note : de combien la dette baisserait si un poste avait été plus faible, toutes choses égales par ailleurs. Il est parlant, parce que l'écart de dépense de retraites avec l'Allemagne est de l'ordre du déficit français. Mais il ne donne pas une part : le même exercice mené sur d'autres postes où la France dépense plus, ou sur les impôts, où elle prélève davantage, ne s'additionne pas à 100 %. Nicolas Dufourcq (*La dette sociale de la France*, 2025) applique au contraire un prorata simple : 57 % de la dépense publique étant sociale, « 2 000 milliards au minimum » de la dette le seraient, ce qui revient à la règle M4 appliquée à toute la dette, y compris celle d'avant 1995.

L'Institut des politiques publiques (Bach, Bozio, De Brouwer et Eryzhenskiy, 2026) arrive par une autre voie à la même conclusion de méthode : présenter les soldes hors transferts n'est pas plus pertinent que les soldes publiés, parce qu'attribuer un solde à une administration n'a de sens que si elle maîtrise ses dépenses et ses recettes. Ni les collectivités, dont les ressources sont devenues pour l'essentiel des fractions d'impôts nationaux, ni la sécurité sociale, dont

l'État fixe les recettes et une partie des prestations, ne sont dans ce cas. Les auteurs proposent de distinguer, dans chaque transfert, ce qui finance une politique de l'État exécutée par délégation de ce qui comble un déséquilibre, sans le chiffrer, faute de documentation budgétaire suffisante. François Ecalle (Fipeco) en tire depuis 2019 la conclusion la plus nette : le solde de la sécurité sociale, et par symétrie celui de l'État, « n'a plus guère de signification » ; seul celui de l'ensemble des administrations en a une.

6. Limites et prolongements

Quatre limites comptent pour la lecture des résultats. La dette de 1995 n'est pas réattribuée ; les comptes de l'Insee en base 2020 remontent plus loin pour l'ensemble des administrations, mais pas, à notre connaissance, pour les transferts entre sous-secteurs. L'État et les ODAC sont agrégés, ce qui neutralise la reprise de la dette de SNCF Réseau en 2020 et 2022 mais empêche de distinguer les deux. Les hôpitaux sont dans la sécurité sociale, si bien que les règles par sous-secteur ne séparent pas l'assurance maladie de l'hôpital public. Enfin, la dette est brute : les réserves des régimes complémentaires (que les données utilisées ne permettent pas de chiffrer) réduiraient la part sociale d'une mesure nette.

Deux prolongements amélioreraient la règle de ressources propres : utiliser les séries d'exonérations compensées des annexes aux lois de financement pour construire la variante cohérente décrite en section 3, et isoler les contributions d'équilibre aux régimes de fonctionnaires, qui sont enregistrées comme des cotisations.

A. Méthode

Données. Eurostat, `gov_10a_main` (dépenses, recettes, solde, intérêts, transferts courants D7 et en capital D9 versés à chaque autre sous-secteur), `gov_10a_taxag` (impôts reçus par sous-secteur), `gov_10a_exp` (dépense par fonction COFOG des administrations publiques, jusqu'en 2024) ; Insee, dette trimestrielle de Maastricht par sous-secteur, contributions consolidées (État, ODAC, APUL, ASSO), valeurs de fin d'année.

Dynamique. Soit D_t la dette des administrations publiques, P_t leur déficit primaire, F_t l'ajustement stock-flux et r_t le taux apparent (intérêts de l'année rapportés à D_{t-1}). On a $D_t = (1 + r_t)D_{t-1} + P_t + F_t$. Chaque règle répartit P_t entre sous-secteurs, $P_t = \sum_j P_{jt}$; la dette attribuée suit $N_{jt} = (1 + r_t)N_{j,t-1} + P_{jt}$, avec $N_{j,1995} = 0$. Le stock de 1995 et les ajustements stock-flux sont capitalisés au même taux et laissés à l'émetteur. Les intérêts suivent ainsi la dette attribuée : une dette imputée à la sécurité sociale porte ses intérêts, même si c'est l'État qui les paie.

Prorata (M1, M4). $P_{jt} = P_t\, G_{jt} / \sum_k G_{kt}$, où G_{jt} est la dépense hors intérêts et hors transferts aux autres administrations du sous-secteur j (M1), ou la dépense hors intérêts de la fonction j (M4 ; la part de 2024 sert pour 2025).

Transferts suivis (M2, M3, M3+). Soit d_j le déficit primaire du sous-secteur j, E_j ses emplois hors intérêts, τ_{ij} la part de ses emplois que i transfère à j, et $s_j = 1 - \sum_k \tau_{jk}$ la part qu'il dépense lui-même. L'emprunt dont dispose j, le sien et celui qu'il reçoit par transferts, vérifie $e_j = d_j + \sum_i e_i \tau_{ij}$; on lui attribue $P_j = s_j e_j$, la part qui finance sa propre dépense. La

somme des P_j est égale au déficit total. Dans M3 et M3+, l'impôt affecté g est retiré des recettes du bénéficiaire et ajouté à celles de l'État, qui le reverse ($d_{\text{État}} - g$, $d_j + g$, $E_{\text{État}} + g$, $\tau_{\text{État},j}$ augmenté de $g/E_{\text{État}}$).

Références

Bach, L., Bozio, A., De Brouwer, O. et Eryzhenskiy, I. (2026), « Qui est responsable du déficit public ? », in *Perspectives budgétaires*, Institut des politiques publiques, juin 2026, chap. 1.

Beaufret, J.-P. (2023), « Retraites obligatoires et déficits publics. Pour la clarté », *Commentaire*, n° 182, p. 245-254.

Beaufret, J.-P. (2026), « Les comptes de la Sécurité sociale et le redressement des finances publiques », *Commentaire*, n° 193, p. 107-112 (non lu ; cité par Bach et al., 2026).

Catherine, S. (2026), calcul publié sur X, repris par F. Tostivint, *JeChange*, 18 août 2026, jechange.fr/credit/news/dette-france-58-pib-retraites-allemandes (source secondaire).

Cour des comptes (2025), *Rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale*, mai 2025 (cité par Bach et al., 2026).

Dufourcq, N. (2025), *La dette sociale de la France 1974-2024*, Odile Jacob (non lu ; cité par la presse).

Ecalle, F. (2019), note Fipeco sur le solde de la sécurité sociale (citation relevée par recherche, non lue en entier).

Eurostat (2013), *Système européen des comptes, SEC 2010*, §1.78.

Fipeco (2026), « Le solde et la dette des administrations de sécurité sociale », fiche de l'encyclopédie, mai 2026.